



RESUMO DE AULA · JORNADA DA LEITURA

Mensuração baseada em processos

CAPÍTULO 4

Como saber se o tratamento está funcionando — e, mais que isso, o que está mudando e por quê. Do viés otimista do julgamento clínico ao modelo idionômico, com instrumentos construídos a partir da rede daquele paciente.

PROFESSOR E PSICÓLOGO CLÍNICO

Júlio Gonçalves

MSc · CRP 12/17614

Aprenda muito mais na

Comunidade Lógica Psicológica

Uma comunidade para quem quer:

- Ψ **Aprofundar o raciocínio clínico** com conteúdos que unem ciência, processos e análise funcional.
- Ψ **Estruturar uma prática ética e coerente**, com pensamento crítico e evidências atualizadas.
- Ψ **Desenvolver o self clínico** por meio de supervisão, leituras guiadas e construção em rede.

Clique aqui e saiba mais



O ESSENCIAL

- Ψ **O julgamento clínico isolado é otimista demais.** Terapeutas tendem a se avaliar acima da média e a superestimar a melhora dos seus pacientes — enquanto 5% a 10% deles pioram durante o tratamento.
- Ψ **Medir não é uma etapa inicial que se encerra.** A mensuração percorre a psicoterapia inteira e é construída junto com o paciente.
- Ψ **Escala responde “melhorou?”; processo responde “o que mudou e por quê”.** São perguntas diferentes, e a segunda é a que sustenta a TBP.
- Ψ **O modelo idionômico inverte a ordem.** Modela-se primeiro o indivíduo, e só depois se busca o padrão de grupo — porque comparar alguém com a média pressupõe uma estabilidade que os dados humanos não têm (erro ergódico).
- Ψ **Na prática:** poucos itens, breves, frequentes, com ancoragem temporal e escala de 0 a 100 — escritos com as palavras do próprio paciente.

Por que medir: o julgamento clínico não basta

Os três encontros anteriores trataram do surgimento da TBP e de sua oposição à lógica diagnóstica, dos domínios e processos básicos do funcionamento humano, e da leitura em rede. Este dá o passo seguinte: **como obter mais precisão nas relações causais** que a rede propõe.

Antes disso, uma ênfase que abriu o encontro: a TBP **não é um modelo simples**. Ela exige repertório real em cada domínio — neuropsicologia para os processos atencionais, psicologia cognitiva para cognição e *self*, e assim por diante. Sem esse domínio conceitual não se aprende a derivar relações causais individualizadas; e sem elas, não há o que medir com sentido.

A pergunta que abre o tema é desconfortável e simples: **como você sabe que o tratamento está funcionando?** Quais critérios você usa para dizer que o paciente melhorou? Qual foi o efeito das suas intervenções?

A resposta honesta costuma envolver expertise, escuta e construção colaborativa — tudo legítimo. O problema é que o julgamento clínico, isolado, tem vieses documentados. Num estudo sobre autoavaliação de profissionais de saúde mental, a maioria dos clínicos avaliou as próprias habilidades como acima da média e estimou taxas de melhora na casa de **80% ou mais** (Walfish, McAlister, O'Donnell & Lambert, 2012). Os desfechos reais não acompanham essa estimativa. E há um dado que quase nunca aparece na percepção do terapeuta: **cerca de 5% a 10% dos pacientes pioram durante o tratamento** (Hansen, Lambert & Forman, 2002; Lambert, 2013).

Não é uma acusação de incompetência — é uma limitação estrutural de quem observa de dentro. É exatamente essa limitação que a mensuração sistemática cobre.

De onde vem a mensuração: RCI, ROM e MBC

A mensuração em psicologia não nasceu com a TBP. Cada degrau resolveu um problema e deixou outro em aberto.

- Ψ **Psicometria clássica.** Escalas padronizadas deram à área linguagem comum e comparabilidade — ao custo de sempre comparar o indivíduo com uma média.
- Ψ **RCI — Índice de Mudança Confiável** (Jacobson & Truax, 1991). Permite calcular se a mudança de um paciente específico é confiável e clinicamente significativa, a partir de dados **intraindividuais**.
- Ψ **ROM — Routine Outcome Monitoring.** Com o OQ-45 (Lambert et al., 1996) consolidou-se o monitoramento rotineiro do desfecho com devolutiva ao terapeuta. Metanálises indicam que sistemas de *feedback* melhoram desfechos, sobretudo nos casos que estão indo mal (Lambert, Whipple & Kleinstäuber, 2018).
- Ψ **MBC — Measurement-Based Care.** Deslocou o foco do instrumento para o **processo de decisão clínica** informado por medidas (Scott & Lewis, 2015; Fortney et al., 2017).

E então a **crítica idionômica**. Hayes e Hofmann levantam a questão que reorganiza o campo: estamos medindo apenas se houve melhora, ou também o *que está mudando e por quê?* Daí o termo **idionômico** — *ídio* (os processos do indivíduo) com *nomo* (o padrão geral), numa ordem definida: o indivíduo vem antes da média.

Nomotético, ideográfico, idionômico

- Ψ **Nomotético.** Busca padrões universais: compara o paciente com a média de uma amostra. Sustenta pontos de corte e tabelas normativas.
- Ψ **Ideográfico.** Foca a mudança intraindividual: compara o paciente consigo mesmo ao longo do tempo.
- Ψ **Idionômico.** Não é meio-termo, é ordem de operações. Modela-se o indivíduo primeiro; o achado de grupo entra depois, se melhorar o ajuste ao caso.

O erro ergódico

Um sistema é **ergódico** quando a média do grupo num dado momento equivale à média do indivíduo ao longo do tempo — o que exige variáveis homogêneas entre pessoas e estáveis no tempo. Processos psicológicos raramente atendem a essas condições (Molenaar, 2004). Extrair a compreensão de um indivíduo a partir da média de um grupo é, portanto, um **erro formal** — não apenas uma imprecisão. É esse problema que empurra o campo para a lógica de rede.

O QUE ISSO MUDA NA CLÍNICA

Se o seu paciente não é a média, o escore normativo deixa de ser o veredito e vira **uma das fontes** de informação. A pergunta central passa a ser: como estes processos se relacionam e variam dentro desta pessoa, ao longo do tempo?

O MBC como raciocínio clínico

O MBC é melhor entendido como **raciocínio clínico** do que como conjunto de escalas. Seus movimentos — **avaliar, formular, revisar** — não são etapas que se cumprem e se abandonam: recorrem durante todo o tratamento.

O ciclo só se fecha quando os dados são **compartilhados com o paciente**, o *feedback* dele é coletado e a decisão clínica é tomada com base nisso. Medir e guardar o resultado para si não é MBC.

- Ψ **Transtéorica** — não pertence a uma abordagem.
- Ψ **Frequente**, com instrumentos **breves**.
- Ψ **Sensível** a mudanças clinicamente significativas.
- Ψ **Relevante para os dois lados** — paciente e terapeuta.
- Ψ **Ampla no foco**: não só sintoma, mas funcionamento global e processos do tratamento.

Os tipos de medida

- Ψ **Escalas padronizadas de autorrelato**. Viés nomotético por construção: interpretadas por pontos de corte (como na DASS-21) ou tabelas normativas.
- Ψ **Medidas individualizadas por metas**, como a *Goal Attainment Scaling* (Kiresuk & Sherman, 1968).
- Ψ **Registros de automonitoramento**: diários e Avaliação Ecológica Momentânea (AEM).

Lendo uma escala padronizada de modo ideográfico

Primeira manobra: nem toda mudança de escore é clinicamente significativa, e o RCI é uma das formas de checar isso. **Segunda**: olhar **item a item**, e não só o escore total — o item traz informação qualitativa sobre o impacto de um processo específico na vida daquele paciente.

A PBAT e o mapa das medidas de processo

A **PBAT** (*Process-Based Assessment Tool*; Ciarrochi, Sahdra, Hofmann & Hayes, 2022) foi construída sobre o metamodelo evolucionário estendido, com um ou dois itens por domínio, para auxiliar na mensuração de processos e no preenchimento da formulação em rede. **Não é uma escala**, e sim um

conjunto de itens para uso idionômico e coleta de alta densidade temporal — por isso não se valida pela psicomетria clássica, mas por modelos de caso único (Sanford et al., 2022).

USO NO BRASIL

A PBAT **não tem validação estabelecida no país**. No encontro apresentou-se um recorte de amostra dos Estados Unidos, e o uso local foi recomendado em perspectiva **qualitativa** — como roteiro de entrevista, por exemplo —, não como instrumento com interpretação normativa.

Há ainda um mapa útil. Hayes, Hofmann e Ciarrochi (2020) varreram a literatura mundial sobre mediação em ensaios de intervenções psicológicas — cerca de 55 mil estudos examinados — e identificaram **72 medidas** que mediam desfechos de forma replicada, cruzando-as com as dimensões do EEMM. Quando você precisa medir um processo específico, existe um conjunto de instrumentos já testados como mediadores — em vez de escolher escala por familiaridade.

Da rede ao formulário: AEM na prática

O encontro trabalhou com **Ana** (caso fictício), engenheira de software com ansiedade, isolamento social e perfeccionismo rígido no trabalho. A rede reuniu dimensões psicológicas, ocupacionais e fisiológicas para identificar processos mantenedores — entre eles evitação de tarefas e fusão cognitiva.

Definidos os processos-alvo, o passo seguinte foi construir a medida: usar a PBAT, ou adaptar itens de medidas existentes — o exemplo foi o AAQ-II — para montar um formulário personalizado de AEM.

O que é AEM, e como escrever os itens

A Avaliação Ecológica Momentânea é a coleta de dados **em tempo real, no ambiente natural** do paciente (Stone & Shiffman, 1994; Shiffman, Stone & Hufford, 2008). Na prática, formulários breves no celular; em indicadores fisiológicos, dados de *smartwatch*.

- Ψ **Breves** — poucos itens, respondidos em segundos.
- Ψ **Com ancoragem temporal explícita** — “neste momento”, “na última hora”.
- Ψ **Capturando contexto** — onde o paciente está, com quem.
- Ψ **Intensidade de 0 a 100**, que aumenta a sensibilidade da percepção em comparação com escalas curtas.

Um exemplo real

Foi demonstrado um instrumento de AEM construído para um paciente usando **a terminologia dele próprio** — inclusive uma escala nomeada por ele como “vibe de conquista”. O instrumento testou uma hipótese da formulação: que um desempenho acima da média levava à exaustão e, no dia seguinte, a

comportamentos compulsivos. Os dados confirmaram a relação e devolveram ao paciente um *feedback* imediatamente utilizável.

É o melhor resumo prático do tema: a medida não veio de um catálogo — veio da rede daquele caso, e falava a língua de quem respondia.

DESAFIOS

Sobrecarga e adesão são o principal obstáculo: formulário demais mata a coleta. A **psicoeducação é parte do método**, não preliminar dele. E vale a ênfase com que o encontro se fechou: **a mensuração não precede a psicoterapia, percorre a psicoterapia.**

Referências

1. Ciarrochi, J., Sahdra, B., Hofmann, S. G., & Hayes, S. C. (2022). Developing an item pool to assess processes of change in psychological interventions: The Process-Based Assessment Tool (PBAT). *Journal of Contextual Behavioral Science*, 23, 200–213.
2. Fortney, J. C., et al. (2017). A tipping point for measurement-based care. *Psychiatric Services*, 68(2), 179–188.
3. Grove, W. M., Zald, D. H., Lebow, B. S., Snitz, B. E., & Nelson, C. (2000). Clinical versus mechanical prediction: A meta-analysis. *Psychological Assessment*, 12(1), 19–30.
4. Hansen, N. B., Lambert, M. J., & Forman, E. M. (2002). The psychotherapy dose-response effect and its implications for treatment delivery services. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 9(3), 329–343.
5. Hayes, S. C., Ciarrochi, J., Hofmann, S. G., Chin, F., & Sahdra, B. (2022). Evolving an idiomorphic approach to processes of change. *Behaviour Research and Therapy*, 156, 104155.
6. Hayes, S. C., Hofmann, S. G., & Ciarrochi, J. (2020). A process-based approach to psychological diagnosis and treatment. *Clinical Psychology Review*, 82, 101908.
7. Jacobson, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical significance: A statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 59(1), 12–19.
8. Kiresuk, T. J., & Sherman, R. E. (1968). Goal attainment scaling. *Community Mental Health Journal*, 4(6), 443–453.
9. Lambert, M. J. (2013). Outcome in psychotherapy: The past and important advances. *Psychotherapy*, 50(1), 42–51.
10. Lambert, M. J., Whipple, J. L., & Kleinstäuber, M. (2018). Collecting and delivering progress feedback: A meta-analysis of routine outcome monitoring. *Psychotherapy*, 55(4), 520–537.
11. Meehl, P. E. (1954). *Clinical versus statistical prediction*. University of Minnesota Press.
12. Molenaar, P. C. M. (2004). A manifesto on psychology as idiographic science. *Measurement*, 2(4), 201–218.
13. Sanford, B. T., et al. (2022). Toward empirical process-based case conceptualization. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 25, 10–25.
14. Scott, K., & Lewis, C. C. (2015). Using measurement-based care to enhance any treatment. *Cognitive and Behavioral Practice*, 22(1), 49–59.
15. Shiffman, S., Stone, A. A., & Hufford, M. R. (2008). Ecological momentary assessment. *Annual Review of Clinical Psychology*, 4, 1–32.
16. Stone, A. A., & Shiffman, S. (1994). Ecological momentary assessment (EMA) in behavioral medicine. *Annals of Behavioral Medicine*, 16(3), 199–202.

17. Walfish, S., McAlister, B., O'Donnell, P., & Lambert, M. J. (2012). An investigation of self-assessment bias in mental health providers. *Psychological Reports*, 110(2), 639–644.

NOTA DE MÉTODO

O caso “Ana” é fictício, apresentado como tal em aula; o exemplo de instrumento individualizado foi desidentificado. Corrigi artefatos de transcrição: *PEBAT* → **PBAT**; *Reis e Hoffman* → **Hayes e Hofmann**; *OK 45* → **OQ-45**; *DAS 21* → **DASS-21**; *AQ2* → **AAQ-II**. O número de medidas replicadas foi ajustado para **72**, conforme publicado. Sobre a triangulação: em aula afirmou-se que combinar método estatístico e clínico rende mais do que qualquer um isolado; a literatura clássica sustenta algo diferente — métodos mecânicos tendem a **igualar ou superar** o julgamento clínico isolado (Meehl, 1954; Grove et al., 2000). A revisão sistemática sobre aplicativos de AEM foi citada em aula sem identificação da fonte e não recebeu citação atribuída.

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão — e salve o PDF para acompanhar.

Escolhi 2 ou 3 processos-alvo a partir da formulação em rede — não a partir da minha escala favorita.

Cada processo-alvo tem medida correspondente, breve, com ancoragem temporal e escala de 0 a 100.

Os itens usam as palavras que o paciente de fato usa.

Combinei com o paciente para que serve medir, e ele sabe o que faremos com os dados.

Tenho um momento previsto para devolver os dados a ele e decidir junto o próximo passo.

Checei quanto tempo por dia estou pedindo — e se não estou pedindo demais.

MINHAS ANOTAÇÕES — O QUE LEVO PARA A CLÍNICA

Para revisar — resposta

Responda com suas palavras. O PDF guarda o que você escrever.

1. Que evidência sustenta a afirmação de que o julgamento clínico isolado é insuficiente para monitorar desfecho?

2. Qual a diferença entre ideográfico e idionômico — e por que a ordem das operações importa?

3. O que é o erro ergódico, e por que ele inviabiliza a leitura puramente normativa de um caso?

4. Cite duas formas de extrair leitura ideográfica de uma escala padronizada.

5. Por que a PBAT não é validada pela psicometria clássica, e que uso dela é defensável no Brasil hoje?

6. Pense num paciente seu com evitação como processo central: escreva três itens de AEM para ele.